УРОК 27. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ COVID.

ПОДГОТОВКА К БЕРЕМЕННОСТИ.

При первых признаках простуды, гриппа, ОРЗ или COVID необходимо принять витамин С и D по схеме.

Также при подозрении на COVID следует иметь в аптечке следующие нутрицевтики, которые входят в схему лечения COVID.

СХЕМА НУТРИЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ВО ВРЕМЯ COVID

(можно принимать с антибиотиками,

все препараты принимаются вместе не меньше 2-х недель):

- Витамин С 2000 – 4000 мг/день;
- Витамин D – однократно 20 000 МЕ, в следующие дни по 5000 МЕ 2-3 раза в день, если нет проблем с почками;
- Цинк – 30 мг 2-3 раза в день;
- Йод – 250 мкг/день;
- Глутатион 1000 мг/день;
- Монолаурин по 500 мг 3-6 раз в день;
- Кошачий коготь по 500 мг 3 раза в день;
- Омега-3 по 1000 мг/день;
- Магний по 800 мг/день;
- Трансфер фактор Кардио по 2 капсулы 2-3 раза в день;
- Коэнзим Q10 (при обострении сердечных проблем) 200 мг в день в форме убихинона;
- Пробиотик;
- АЦЦ лонг для облегчения вывода мокроты – 600 мг/день.

Во время COVID питание строго по чувству голода.

В рацион обязательно должны входить:

- зелень, сырые салаты, ягоды, немного фруктов;
- термообработанные овощи;
- легкий белок: птица, рыба, морепродукты;
- яйца, сливочное масло, топленное сливочное масло;
- воды для разжижения крови.

Исключить алкоголь, кофе, черный чай – эти напитки сгущают кровь.

После полного выздоровления необходимо обязательно проверить ряд показателей крови, т.к. COVID бьет по самым слабым местам в организме и истощает запасы белка, железа, микроэлементов, витаминов группы В и жирорастворимые витамины.

СПИСОК АНАЛИЗОВ ПОСЛЕ COVID:

- ферменты печени (АСТ, АЛТ), особенно если в лечении использовались антибиотики;
- общий билирубин;
- щелочная фосфатаза;
- общий белок (обычно сильно снижается после COVID);
- гомоцистеин;
- витамин D3;
- витамины B12, B9, B6;
- гормоны щитовидной железы: ТТГ, Т3, Т4 (свободные), АТ-ТПО, АТ-ТГ;
- йод, селен;
- гемоглобин и ферритин;
- цинк, медь.

НУТРИЦЕВТИКИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ COVID

(препараты принимаются в комплексе не менее 2-х месяцев):

- Витамин D в зависимости от анализа;
- Витамин С в липосомальной форме от 1000 до 1500 мг/день;
- NAC по 500 мг 2 раза в день;
- Кверцетин по 500 мг 2 раза в день;
- Монолаурин по 500 мг 3 раза в день;
- Пробиотики на выбор;
- Магний цитрат/бисглицинат по 400 мг/день;
- Витамины B12, B9, B6 в зависимости от анализа;
- Омега-3 – 2 г/день;
- Лецитин из расчета 10 г на 1 кг веса;

- Витамин А по 3000 мкг (10 000 МЕ)/день;
- Йод и селен в зависимости от анализа и УЗИ;
- L-тирозин по инструкции на упаковке;

+ ЖЕЛЕЗО (перорально или внутримышечно)

COVID и АНТИБИОТИКИ

Пандемия коронавируса спровоцировала массовый прием антибиотиков без явных показателей для профилактики инфекции, «на всякий случай».

Но, это опасно, как для заболевших ковидом, так и для человечества в целом, т.к. применение антибиотика «на всякий случай» только усиливает устойчивость бактерий к антимикробным лекарствам и в критический, действительно нужный момент, они могут не сработать.

Участковые врачи в поликлиниках часто без анализов и полного обследования назначают антибиотики, руководствуясь шаблонным мышлением: если ковид, то может быть пневмония, а пневмония – это инфекция дыхательных путей, поэтому нужно назначать антибиотики.

На сегодня сотням тысяч больных назначены антибиотики без показаний и сдачи анализов.

По данным ВОЗ антибиотики назначались 72% пациентов с ковид.

Антибиотики с вирусом не работают и на начальном этапе заболевания они не нужны. Антибиотики работают только с бактериальной инфекцией, которая МОЖЕТ развиться на фоне вирусной нагрузки.

Несмотря на сходство – вирусную пневмонию и дыхательную недостаточность при ковид, в отличие от гриппа, бактериальные инфекции развиваются только у 7-8% госпитализированных больных.

По этой причине ВОЗ НЕ рекомендует использовать антибиотики при легком течении ковид.

А при среднетяжелом течении ковид антибиотики нужно назначать, только если есть симптомы бактериальной инфекции.

Если доктор назначает антибиотик без ОАК с развернутой лейкоцитарной формулой, то обратитесь к другому врачу.

Чем больше антибиотиков назначается необдуманно, тем больше возникает устойчивых к ним бактерий, а значит тем больше развиваются смертельно опасные суперинфекции в реанимациях больниц, когда, не выздоровев от одной инфекции, человек заражается другой.

ТИП ИНФЕКЦИИ ПО ОАК

АНАЛИЗ	Бактериальная, грибковая инфекция	Вирусная инфекция
СОЭ (ESR)	Повышены	Повышены
Нейтрофилы (NEUT)	Повышены	Снижены
Лимфоциты (LYM)	Снижены	Повышены
Лейкоциты (WBC)	Повышены	Снижены
Моноциты (MON)	Повышены	Повышены

Руководствуясь таблицей вы всегда можете перестраховаться и узнать, есть ли у вас бактериальная инфекция, которая вызывает осложнения при COVID.

При наличии бактериальной инфекции назначение антибиотиков врачом может быть оправдано**.**

ПОДГОТОВКА К БЕРЕМЕННОСТИ

ПОДГОТОВКА К БЕРЕМЕННОСТИ СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ЭТАПОВ:

1. РАБОТА С ПОЛОВЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ (за 3 – 6 месяцев до планируемой беременности).

Работать с половыми инфекциями нужно до, а не во время беременности.

До беременности нужно сдать следующие анализы на половые инфекции:

- антитела к вирусу гепатита С и В;
- антитела к ВИЧ 1,2;
- сифилис RPR;
- chlamydia trachomatis - выявление активного хламидиоза;
- candida albicans – выявление кандидоза;
- gardnerella vaginalis - выявление баквагиноза, но может обнаруживаться и у здоровых женщин;
- mycoplasma genitalium - выявление активного микоплазмоза;
- neisseria gonorrhoeae - выявление активной гонореи;
- trichomonas vaginalis - выявление активного трихомониаза;

- вирусы папилломы человека типы 16 и 18 - выявление активной ВПЧ-инфекции наиболее онкогенных типов;
- цитомегаловирус (мазок) - выявление активной ЦМВ-инфекции.

2. **РАБОТА С ПИТАНИЕМ, БЕЛКОМ И ЖКТ** (по симптомам), с обязательной работой над желчеоттоком, т.к. токсизоз во время беременности и рвота желчью по утрам – исключительно связано с нарушением желчеоттока.

3. **РАБОТА С ДЕФИЦИТАМИ (за 3 – 6 месяцев до планируемой беременности).**

ЧЕК ЛИСТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К БЕРЕМЕННОСТИ:

- УЗИ органов брюшной полости и почек;
- ОАК с СОЭ (контроль гемоглобина не ниже 125 и СОЭ не выше 10);
- УЗИ щитовидной железы;
- ТТГ, Т3 + Т4, АТ-ТПО;
- Общий белок (оптимум 72-78);
- Витамин В12, В9 и В6 (должны стремиться к верхней границе референса);
- Гомоцистеин (оптимальная норма до 8);
- Билирубин (оптимальная норма до 10-15 ммоль/л);
- Витамин D3 (оптимальная норма от 60);
- Холестерин: общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП;
- Ферритин (оптимум должен стремиться к верхней границе референса);
- Глюкоза + инсулин;
- Гликированный гемоглобин;
- Магний, Цинк, Медь, Марганец (должны стремиться к верхним границам референса)
- Йод в сыворотке крови (от середины референса) + селен (должен стремиться к верхней границе референса).

АНАЛИЗЫ НА ПАРАЗИТОВ:

1. Антитела к Toxoplasma gondii IgG (количественный)
2. Антитела к антигенам аскарид IgG
3. Антитела к антигенам лямблий суммарные
4. Антитела к антигенам описторхисов IgG
5. Антитела к антигенам токсокар IgG
6. Антитела к антигенам трихинелл IgG
7. Антитела к антигенам эхинококка IgG

К ЧЕМУ МОГУТ ПРИВЕСТИ ДЕФИЦИТЫ:

ДЕФИЦИТ МАРГАНЦА может привести к судорогам у детей и запаздыванию психомоторного формирования ребенка. Недостача этого вещества у беременных

может быть причиной врожденных отклонений у плода, аномальное формирование конечностей, сращение суставов и деформирование черепа.

ПОВЫШЕННЫЙ ГОМОЦИСТЕИН может быть причиной замершей беременности, врожденных пороков, бесплодия.

ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ может привести к тяжелым патологиям плода и даже вызвать преждевременные роды, выкидыши.

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА В9 может привести к дефектам нервной трубки у плода, заячьей губе, ребенок впоследствии может страдать психозами, неврозами или задержкой умственного развития.

Если женщина репродуктивного возраста планирует беременность, то ей необходим обязательный дополнительный прием фолатов (суточная доза не менее 400 мкг) хотя бы за 3 месяца до наступления беременности. Дотация фолиевой кислоты обязательна и в течение всего первого триместра в суточной дозировке.

ДЕФИЦИТ ЙОДА может привести к выкидышам, врожденным аномалиям плода, смерти плода. У новорожденного могут быть множественные пороки развития, умственная осталось, глухонемота, косоглазие.

ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА может привести к выкидышам, преждевременным родам, задержке внутриутробного развития плода, рождению детей с низким весом, двухкратному увеличению риска преждевременных родов.

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D может привести к прерыванию беременности в I и II триместрах, развитию плацентарной недостаточности, нарушений сократительной активности матки, увеличение риска кесарева сечения.

ДЕФИЦИТНАЯ МАМА = ДЕФИЦИТНЫЙ МАЛЫШ

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:

1. Как нужно питаться во время COVID?
2. Почему важно пить воду?
3. Какие напитки сгущают кровь?
4. Какие анализы нужно сдать после COVID?
5. Что важно знать при назначении антибиотиков при COVID?
6. Расскажите про три этапа подготовки к беременности.
7. К чему может привести высокий гомоцистеин во время беременности.
8. Почему важно убрать до зачатия дефицит В9?
9. К чему может привести инсулинорезистентность во время беременности?
10. К чему может привести дефицит йода во время беременности?